4ª ristampa, dicembre 2007
1ª edizione, maggio 2005
© copyright 2005 by Carocci editore S.p.A., Roma

Finito di stampare nel dicembre 2007
dalle Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

ISBN 978-88-7466-179-4

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia,
anche per uso interno o didattico.

Direzione dell'opera

Maria Dal Pra Ponticelli
Professore associato di Servizio sociale
Università di Siena

Comitato scientifico

Elena Allegri (Epistemologia del servizio sociale)
Ricercatore di Sociologia generale e Servizio sociale
Università del Piemonte Orientale (Alessandria)

Annamaria Campanini (Metodologia del servizio sociale)
Professore associato di Metodi e tecniche del servizio sociale
Università della Calabria

Milena Diomede Canevini (Deontologia del servizio sociale)
Già preside della Scuola operatori sociali, Regione Lombardia, e direttrice tecnica della Scuola diretta a fini speciali, Università degli Studi di Milano

Silvana Tonon Giraldo (Politiche sociali)
Docente di Servizio sociale
Università di Trieste e Università di Verona

Luigi Gui (Teorie del servizio sociale)
Ricercatore di Sociologia generale e Servizio sociale
Università di Trieste

Raffaello Maggian (Organizzazione dei servizi sociali)
Docente di Organizzazione dei servizi sociali
Università di Trieste

Elisabetta Neve (Principi e fondamenti del servizio sociale)
Docente di Principi e fondamenti del servizio sociale
Università di Verona

Aurelia Tassinari (Storia del servizio sociale)
Docente di Principi e fondamenti del servizio sociale
Università di Torino

Molti di questi servizi, perlopiù del terzo settore, intrecciano il sapere esperto dei professionisti con il sapere esperienziale di chi è stato, a sua volta, tossicodipendente, prostituta o immigrato clandestino e poi, emancipatosi e divenuto operatore, mantenendo la memoria dei suoi trascorsi valorizza nelle nuove relazioni d'aiuto i linguaggi e gli stili comunicativi più efficaci.
La bassa soglia nei servizi, dunque, rende più fragili e talvolta incerti i confini tra normalità e devianza, tra regolarità e irregolarità, tra identità di persona-operatore e identità di persona-utente, tra progettualità e provvisorietà, ma proprio in questo spazio di possibili "malintesi" favorisce l'osmosi tra il mondo dei servizi e il mondo dell'emarginazione.

CARITAS ITALIANA - FONDAZIONE ZANCAN (a cura di) (1998), *Gli ultimi della fila*, Feltrinelli, Milano.
GUI L. (a cura di) (1995), *L'utente che non c'è*, FrancoAngeli, Milano.
GUIDICINI P., PIERETTI G., BERGAMASCHI M. (a cura di) (1997), *Gli esclusi dal territorio*, FrancoAngeli, Milano.
LA CECLA F. (1997), *Il malinteso*, Laterza, Roma-Bari.
LANDUZZI C., PIERETTI G. (a cura di) (2003), *Servizio sociale e povertà estreme*, FrancoAngeli, Milano.
LEPRI C. (1999), *Lavoro e fasce deboli*, FrancoAngeli, Milano.

BENEFICENZA [▸ Assistenza, storia della]

BENESSERE

Domenico Secondulfo

1. Introduzione Il concetto di benessere (b.) è uno dei più caratteristici delle società moderne e in particolare di quelle della tarda modernità. Con l'ascesa della società borghese, esso si affianca progressivamente a quello di ricchezza, assumendo una importanza simbolica quasi superiore. Negli anni sessanta e settanta le "società del benessere", soprattutto le socialdemocrazie europee, portano il concetto di b. dalla sfera privata a quella pubblica, includendolo nel "pacchetto di cittadinanza" che ne caratterizza la relazione con i propri cittadini. Dopo gli anni ottanta, la progressiva crisi fiscale di questo tipo di società, nonché il progressivo affermarsi della nuova logica neoliberale mettono in crisi il concetto politico-collettivo di b., sia sul piano teorico, sia sul piano fattuale. Da queste riflessioni critiche si sviluppano nuove linee che includono nel concetto di b. gli aspetti relazionali e solidaristici, distaccandosi dalla precedente ottica statalista del welfare state.

2. Definizione Non è facile dare una definizione del concetto di b.: a livello intuitivo pare un concetto autoesplicativo, ma si tratta di un termine che è stato via via riempito di diversi significati e che è ancora in evoluzione, per cui è difficile darne una definizione metastorica e assoluta. Potremmo dire che si tratta di una sensazione piacevole che affonda le radici, da un lato, nella possibilità di uso di una serie di beni materiali (ma anche di servizi) che migliorano l'esistenza individuale e che possono essere privati o pubblici, e dall'altro, nella rassicurazione che questo stato positivo sia socialmente protetto e durerà nel tempo. Esiste poi il versante soggettivo di questa sensazione, che, soprattutto nella tarda modernità, si espande dal livello del corpo a quello della mente, strutturando la ricerca di uno stato positivo olistico e integrato, da perseguire con varie strategie di impegno sia fisico sia mentale, collegandosi con il concetto di "stile di vita". È comunque importante tenere distinto il concetto di b. da quello di ricchezza, poiché la ricchezza è di tipo soprattutto materiale e individuale, mentre il b. assume dimensioni di tipo psicofisico e ha comunque una componente relazionale o sociale che non può essere ignorata. A questo proposito, si richiama il dibattito sulla validità del prodotto interno lordo come misura del b. di una popolazione. Altrettanto importante è tenere distinto questo concetto da quello di salute.

3. Cenni storici e basi teoriche La nascita del concetto di b. va messa in relazione con lo sviluppo della società borghese moderna. In questa fase il concetto di b., inteso in termini essenzialmente materiali e di ricchezza, si scinde da quello di felicità e si propone come sua traduzione mondana e materiale. Il concetto identifica quindi, per il cittadino borghese, il livello di ricchezza, di servizi e di consumi (stile di vita) che egli ritiene sia socialmente giusto godere per il proprio *status* sociale, una prosperità essenzialmente economica e individualistica, frutto soprattutto dell'iniziativa privata. Dalla seconda metà dell'Ottocento, con l'ascesa della borghesia a classe politica dirigente, il b. passa dalla sfera privata alla sfera pubblica, inserendosi tra i fini dell'azione dello Stato, anche in relazione ai problemi e alle tensioni determinati dallo sviluppo industriale e dalle rivendicazioni dei movimenti operai. Il concetto di b. si distacca completamente da quello di felicità, caratterizzandosi come un complesso di elementi soprattutto materiali, economici e di organizzazione sociale, orientato a migliorare il livello di vita, di consumo e di soddisfazione dei citta-

dini. Un processo storico che trova il suo apice nella costituzione del welfare state, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, inteso come garanzia di standard di vita soprattutto materiali da parte dello Stato, che consentono al cittadino un livello di vita superiore alla soglia di povertà socialmente riconosciuta. Una sorta di requisito minimo di b. garantito dalla società, che si impone accanto al concetto precedente (che resta comunque valido), modulandosi, in accordo con la stratificazione sociale, per ceto, classe e gruppo professionale. Successivamente, con l'inizio nella società occidentale della trasformazione postindustriale, al substrato materiale ed economico del concetto di b., ormai dato per scontato e identificato con un *mix* di servizi pubblici garantiti e con l'accesso al mondo dei consumi, si associa sempre più una componente di tipo relazionale, sociale e psicologica, che, se da un lato amplia i confini del concetto di b., dall'altro gli affianca il concetto di qualità della vita come espressione di un b. in cui gli aspetti sociali, relazionali, psicologici e culturali (non materiali) del vivere assumono un'importanza simile a quelli di tipo materiale e di servizio. Va comunque ricordato che questa evoluzione del concetto si lega al passaggio dai bisogni di genere materiale, tipici della fase industriale, a quelli postmateriali, tipici della fase postindustriale, secondo una progressione che comunque vede la possibilità di sviluppo dei secondi fondarsi su una sostanziale e indiscussa soddisfazione dei primi. Alla possibilità di avere (beni, servizi ecc.) si associa la possibilità di essere (partecipare, relazionarsi ecc.).
Si inizia ad affacciare la problematicizzazione del b. inteso unicamente come quantità di beni, sino a mettere in discussione indicatori di sviluppo come il PIL, centrati unicamente sulla produzione materiale e insensibili alla "qualità della vita", lasciando intendere che a un alto b. materiale potrebbe associarsi una bassa qualità della vita, qualora i costi psicologici e sociali del b. materiale fossero troppo elevati. Un'evoluzione simile può essere notata per il concetto di salute, che da un'accezione prevalentemente fisiologica, come assenza di malattia, si sposta sempre di più verso il concetto di b. inteso come uno stato della persona con una propria intrinseca positività, superiore alla semplice assenza di negatività. In questa positività sono inclusi soprattutto quegli aspetti non materiali che entrano a far parte anche del concetto di b., producendo il ponte semantico che avvicina i due concetti. Una modifica che, tra l'altro, favorisce grandemente il ricorso alle medicine non convenzionali, cui i consumatori si rivolgono come maggiormente adatte a incontrare quegli stati di malessere che hanno nelle dimensioni psicologiche e relazionali la loro radice. Nella sua originaria accezione borghese, il concetto di b. si presenta essenzialmente delimitato dalle regole del ceto di appartenenza, in una dimensione tendenzialmente statica. Successivamente, con la società postindustriale e le modifiche che ne conseguono, questo concetto, così come quello intrecciato di salute, assumono, in collegamento con lo sviluppo della società dei consumi, una fortissima spinta espansionistica, trasformandosi in un inseguimento di modelli ideali che, soprattutto nella loro versione individuale e consumistica, sono continuamente migliorabili e quindi mai definitivamente raggiunti. Ciò vale sia sul versante psicologico e relazionale (psicoterapie), sia su quello materiale (consumi), sia infine su quello che si lega al concetto di salute (*fitness*), anche se molto spesso questa spinta, viva soprattutto nel mondo del consumo, entra in frizione con il concetto di qualità della vita, chè si presenta con caratteristiche meno consumistiche e più individualizzanti.

ACOCELLA N. (2002), *Economia del benessere. La logica della politica economica*, Carocci, Roma.
BALZANI R. (a cura di) (1998), *Una borghesia di provincia*, il Mulino, Bologna.
BELLAH R. (1996), *Le abitudini del cuore. Individualismo e impegno nella società complessa*, Armando, Roma.
BENASSI D. (2002), *Tra benessere e povertà*, FrancoAngeli, Milano.
CESARIO S. (2001), *L'autoaiuto psichiatrico. I processi aspecifici nella psicoterapia*, FrancoAngeli, Milano.
FERRARI OCCHIONERO M. (2002), *Disagio sociale e malessere generazionale*, FrancoAngeli, Milano.
FORTUNATI L. (a cura di) (2002), *Corpo futuro*, FrancoAngeli, Milano.
INGLEHART R. (1977), *The Silent Revolution*, Princeton University Press, Princeton.
MAGRAW R. (1998), *Il secolo borghese in Francia. 1815-1914*, il Mulino, Bologna.
MONTI A. (1997), *Alle origini della borghesia urbana*, il Mulino, Bologna.
SECONDULFO D. (2000), *Trasformazioni sociali e nuove culture del benessere*, FrancoAngeli, Milano.
SPALTRO E. (2002) (a cura di), *Benessere e buon lavoro*, FrancoAngeli, Milano.
ZANI B. (1999), *Le vie del benessere. Eventi di vita e strategie di coping*, Carocci, Roma.

BISOGNO

Francesco Villa

1. Definizione e classificazioni Il termine "bisogno" (b.) risulta di difficile concettualizzazione, in quanto è stato analizzato in diversi contesti disciplinari, con esiti generici e complessi nello stesso tempo. Il suo significato più elementare è quello di natura bio-fisiologica, che lo riferisce ai bisogni organici fondamentali della persona (nutrizione, sopravvivenza, riproduzione ecc.). La sua utilizzazione è stata ripresa e si è sviluppata nel